

Quatsch, Zukunftsmusik oder bereits Tägliches Brot?



Psychiatrische Notfälle u. Zustände

Was ist Psychiatrie? – Definition des Faches

Psychiatrie umfasst die Erforschung, Diagnostik und Therapie psychischer Krankheiten des Menschen. Im **Zusammenwirken biologischer und psychosozialer Faktoren und deren Auswirkungen auf das psychopathologische Erscheinungsbild** liegt das Wesen der Psychiatrie. Das zugrunde liegende Krankheitsmodell ist ein bio-psycho-soziales Krankheitsmodell.

Welche Bestandteile könnt ihr benennen?

Das medizinische Fachgebiet **Psychiatrie und Psychotherapie** umfasst die Erforschung, Diagnostik und Therapie psychischer Krankheiten des Menschen.

Das medizinische Fachgebiet „**Psychosomatische Medizin und Psychotherapie**“ umfasst Krankheiten und Leidenszustände, die vorrangig durch psychosoziale und psychosomatische Faktoren mitbedingt bzw. geprägt werden.

- **Psychopharmakologie:** Lehre von der Beeinflussung seelischer Vorgänge durch Psychopharmaka.
- **Sozialpsychiatrie:** Epidemiologie und Soziologie seelischer Krankheiten.
- **Kinder- und Jugendpsychiatrie:** Erforschung und Behandlung seelischer Störungen vom Säuglingsalter bis zur Adoleszenz.
- **Neurologie:** Lehre von den Erkrankungen des zentralen, peripheren und vegetativen Nervensystems.
- **Psychologie:** Lehre von den normalen seelischen Vorgängen. Die „klinische Psychologie“ beschäftigt sich auch mit den psychogenetisch erklärbaren krankhaften seelischen Vorgängen.
- Psychopathologie
- Biologische Psychiatrie
- Psychopharmakotherapie
- Soziotherapie oder psychosoziale Therapien
- Forensische Psychiatrie
- Psychotherapie



In welchem unserer Berufen haben wir dann Kontakt?

Allen!!



Welche Grundannahmen sind für uns zu Beginn wichtig um mit einem solchen Patienten zurecht zu kommen?

Die Landkarte ist nicht das Gebiet.

Wir alle haben verschiedene Vorstellungen von der Welt. Keine dieser Vorstellungen stellt die Welt vollständig und akkurat dar. Menschen reagieren auf ihre Abbildung von der Realität, nicht auf die Realität selbst.

Es gibt keine richtigen und falschen Modelle der Welt.

Jeder sieht die Welt durch eine andere Brille.

Hinter jedem auch noch so problematischem Verhalten/Symptom steckt eine gute Absicht.

Jedes Verhalten bezweckt im Leben des Betreffenden eine positive Funktion, unabhängig von möglichen negativen Nebenwirkungen.

Menschen treffen innerhalb ihres Modells der Welt grundsätzlich die beste ihnen subjektiv zur Verfügung stehende Wahl.

Wenn Menschen andere und angemessenere Möglichkeiten für die Erfüllung ihrer Bedürfnisse zur Verfügung hätten, würden sie vieles von dem nicht tun, was manchmal aus reiner Bosheit zu geschehen scheint.

Für jedes Verhalten gibt es einen Kontext, in dem es sinnvoll oder nützlich sein kann.

Gelernt ist gelernt, d.h. dieses Verhalten hat irgendwann zum gewünschten **Erfolg** geführt. Ziel ist, zusätzlich zu diesem Verhalten mehr Wahlmöglichkeiten zu entwickeln.



Kann man einen möglichen Suizid frühzeitig erkennen?

Es gibt viele Faktoren die „Sein oder Schein“ sein können.
Ein Suizid kann sich vorher ankündigen, MUSS aber nicht unbedingt!

Was glaubt ihr was die inneren Emotionalen
Wünsche dieser Menschen sein kann?

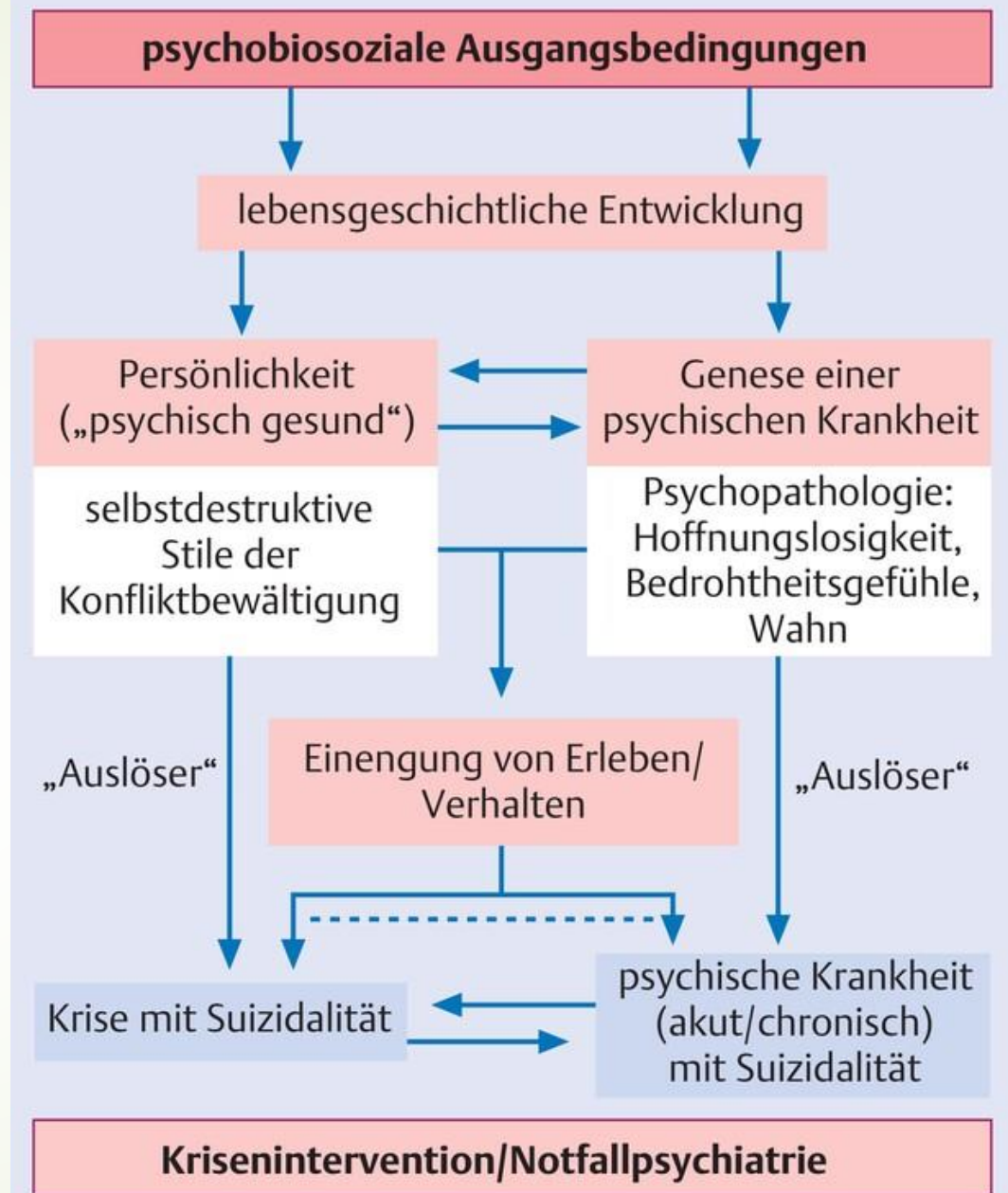


Beispiele von
Argumentationen
von Patienten deren
Versuch nicht
geglückt ist oder
davon abgehalten
werden konnten.

- Todeswunsch
- Wunsch nach Veränderung im Leben
- Hilferuf
- Rache
- Wunsch nach Ruhe
- Wunsch nach Ablösung und Trennung
- Manipulation anderer
- Enttäuschung, Wut
- depressive Verstimmung
- belastende Lebensereignisse
- psychotische Motivation.

Krisenmodell der akuten Suizidalität

Das „**Krisenmodell**“ geht von einer psychisch unauffälligen Persönlichkeit aus. Suizidales Handeln resultiert aus einem nicht bewältigbar erscheinenden Lebensereignis





Suizid - Video

Welche Menschen stellen suizidale Risikogruppen da?

- Auf Grund diverser Untersuchungen ist bekannt, dass die häufigsten Risikopopulationen mit von 1–5 abnehmendem Suizidrisiko die folgenden sind:
 1. Depressive aller Arten
 2. Alkohol-, Medikamenten- und Drogenabhängige,
 3. Alte und Vereinsamte
 4. Personen, die durch eine Suizidankündigung auffallen,
 5. Personen, die einen Suizidversuch hinter sich haben.

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-74271-2_7



Betroffene Berufe?

- Ärzte
- Pflegepersonal
- Rettungsdienst (sowie Feuerwehr)
- Polizisten
- Soldaten
- Chemiker
- Sozialarbeiter
- Künstlerische Berufe
- Landwirte
- Seeleute
- ...

Anzahl der Suizide 2021

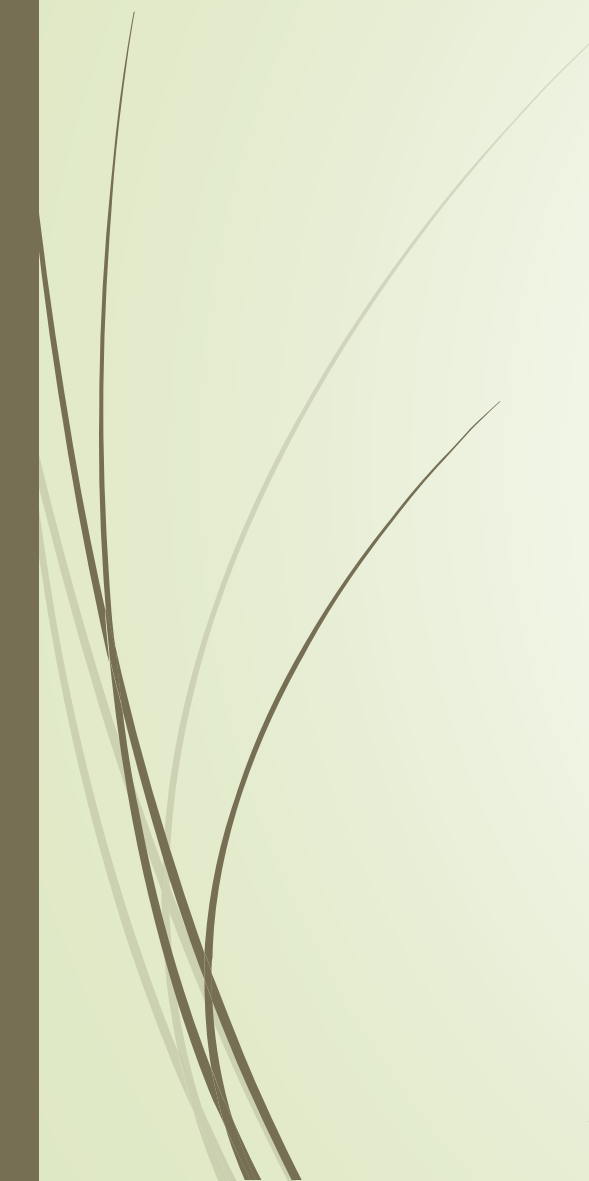
Altersgruppen von ... bis unter ... Jahre	Insgesamt	Männlich	Weiblich
unter 15	27	12	15
15 bis 19	162	118	44
20 bis 24	306	223	83
25 bis 29	326	268	58
30 bis 34	389	308	81
35 bis 39	445	355	90
40 bis 44	457	358	99
45 bis 49	523	390	133
50 bis 54	823	605	218
55 bis 59	1 010	710	300
60 bis 64	830	633	197
65 bis 69	708	516	192
70 bis 74	669	475	194
75 bis 79	673	480	193
80 bis 84	928	679	249
85 bis 89	611	446	165
90 und älter	328	229	99
Insgesamt	9 215	6 805	2 410

Die Tabelle der "[Gestorbenen nach Kapiteln der ICD-10](#)" mit weiteren

Informationen findet sich auch im Informationssystem der

Gesundheitsberichterstattung.

- = Nichts vorhanden.



https://www.bte.dbb.de/fileadmin/user_upload/www_bte_dbb_de/pdf/magazin/2020_1.pdf

Wie Aufmerksam sind wir wirklich ?



Toni Weidenbecher



Erkrankungen/Notfallsituationen

Die Erkrankungen können jeden Komplex der Psychiatrie betreffen, daher wird in Notfallsituationen in der Regel sehr symptomorientiert gearbeitet/behandelt.

Im allgemeinen kann man sagen, dass es sich um schwerwiegende akute Störungen des Denkens, der Stimmung, des Verhaltens oder des sozialen Seins handelt.

- Erregungszustände
- Akute Suizidalität
- Angst- und Panikstörungen
- Bewusstseinsstörungen/Delir
- Stupor und Katatonie
- Drogennotfälle
- Psychopharmakainduzierte Notfälle

Erregungszustände

Hauptcharakteristika von Erregungszuständen sind eine meist ziellose **Steigerung von Antrieb und Psychomotorik, affektive Enthemmung** und **Kontrollverlust**. Es kann zu ausgeprägter Gereiztheit und aggressiven Äußerungen bis hin zu **unvermittelten Gewalttätigkeiten kommen**.

- Erregungszustände können bei den meisten **psychischen Störungen auftreten. Hauptursachen sind:**
 - manische, schizophrene Psychosen
 - Demenzen
 - Intoxikationen/Entzugssyndrome
 - Belastungsreaktionen
 - Persönlichkeitsstörungen
 - Minderbegabung
 - **organische Grunderkrankungen** (hormonelle und Stoffwechselstörungen).



Angst- und Panikstörungen

Ein Notfall liegt vor, wenn der Patient meint, die Kontrolle über sich zu verlieren oder lebensbedrohlich erkrankt zu sein.

Es kommt zu panikartigen Verhaltensweisen mit hochgradiger Erregung und Unruhe.

Somatische Differenzialdiagnosen sind auszuschließen.

Cave! Nur weil Pat eine bekannte Störung hat, muss das nicht bedeuten, dass nicht evtl. doch eine ersthafte organische Erkrankung vorliegt!



Bewusstseinsstörungen

Bewusstseinsstörungen umfassen eine Vielzahl unterschiedlicher Symptome und Schweregrade, deren Spektrum von leichter Benommenheit mit Bewusstseinsstörungen bis zu tiefer Bewusstlosigkeit reichen kann.

Ursächlich können zerebrale, zerebrovaskuläre, kardiovaskuläre, metabolische, toxische, traumatische oder psychische Faktoren zugrunde liegen.

Nach der zeitlichen Dauer können bei der Bewusstlosigkeit die Sekunden bis Minuten dauernde Synkope und das Stunden oder Tage dauernde Koma unterschieden werden.

Synkopen treten besonders bei älteren Patienten in der Allgemeinpraxis häufig auf und können in der Regel ambulant abgeklärt werden.



Delir

- Das delirante Syndrom (Delir) ist hauptsächlich durch **Desorientiertheit, Verkennung der Umgebung, halluzinatorische Erlebnisse** (vorwiegend optisch) und **Unruhe** bis hin zu starker Erregung gekennzeichnet. Es handelt sich dabei um **Akute organische Psychose**, durch Alkoholentzug („Delirium tremens“), Medikamentenentzug, Allgemeinerkrankungen und Einnahme zentral wirksamer Pharmaka.

Hauptformen sind:

- (Alkohol-)Entzugsdelir
- postoperatives Delir
- durch allgemeinmedizinische und hirnorganische Krankheiten bedingtes Delir
- pharmakogenes, z.B. zentrales anticholinerges Delir



Stupor

- Zustand einer psychomotorischen Hemmung mit unterschiedlich ausgeprägter Bewegungs- und Regungslosigkeit (Hypokatatonie), in dem der Kranke bei klarem Bewusstsein ist und auf äußere Reize nicht reagiert, nicht spricht (Mutismus), nicht trinkt und nicht isst, Aufforderungen nicht nachgeht, obwohl er diese wahrnimmt und versteht. Eine Amnesie besteht i. d. R. nicht.
- **Psychiatrische** Ursachen sind Schizophrenie, Depression, psychogener Stupor.



Drogennotfälle

Drogennotfälle zeigen sich vorwiegend als akute **Intoxikationen oder Entzugerscheinungen** sowie als **psychotische Reaktionen**, z. B. in Form eines „Horrortrips“.

Das Erscheinungsbild kann sich auf vielfältige Weise als Bewusstseinsstörung, als delirantes Syndrom oder auch als Erregungszustand zeigen.

Psychopharmakainduzierte Notfälle

Ursachen sind akzidentielle oder suizidale Überdosierungen, Nebenwirkungen oder Absetz-/Entzugssyndrome.

Wichtige Akutnebenwirkungen von Antipsychotika:

- **Frühdyskinesie:** Therapie mit Anticholinergika
- **Malignes neuroleptisches Syndrom:** Symptome sind Fieber, Tremor, Rigor, Bewusstseinsstörungen und vegetative Dysfunktionen. Sofortiges Absetzen der Antipsychotika sowie körpertemperatursenkende und intensivmedizinische Maßnahmen sind erforderlich; Therapieversuch mit dopaminergen Substanzen und Muskelrelaxanzien (z. B. Dantrolen).
- **Serotonin-Syndrom:** Fieber, Tremor, Erregung, Desorientiertheit bei (kontraindizierten!) Medikamentenkombinationen (lebensbedrohlich)
- **anticholinerges Syndrom:** delirantes Bild durch eine (relative) Überdosierung oder eine Kombination anticholinerg wirksamer Pharmaka. Therapie mit Physostigmin
- **kardiovaskuläre Störungen:** unter trizyklischen Antidepressiva und Antipsychotika. Sturzrisiko durch orthostatischen Kollaps
- **weitere:** Harnsperre, (Sub-)Ileus, zerebrale Krampfanfälle



Gibt es noch mehr gefährdete Vorerkrankungen?

- manische, schizophrene Psychosen
- Demenzen
- Intelligenzminderung
- Persönlichkeitsstörungen
- Minderbegabung
- **organische Grunderkrankungen** (Endokrine und Stoffwechselstörungen).
- ...

Zwei Erkrankungen sind für und besonders Wichtig und kommen in jedem Alter vor.

Schizophrenie *Depression*

Depressionen

- Ein Teil der Depressiven kann aufgrund des äußeren Aspektes erkannt werden
- In anderen Fällen werden (fast) ausschließlich körperliche Beschwerden geschildert (larvierte Depression). Bei Verdacht muss die Symptomatik gezielt exploriert werden

depressive Verstimmung / Niedergeschlagenheit
Antriebshemmung
Denkhemmung
Schlafstörungen
Interesse- und Initiativeverlust
Entscheidungsunfähigkeit
Angst, Hoffnungslosigkeit
innere Unruhe
Grübeln
Vitalstörungen.

Bei depressiven Patienten besteht ein **ausgeprägtes Suizidrisiko**. Die Suizidrate ist mit etwa 4% ca. 30-mal höher als in der Durchschnittsbevölkerung. 15 % der Patienten mit schweren depressiven Störungen begehen Suizid, 20 bis 60 % weisen Suizidversuche in ihrer Krankheitsgeschichte auf, 40–80 % leiden während einer Depression an Suizidideen.

Häufigkeit der Symptome bei Depressionen

Es betrifft aber **nicht** nur die Erwachsenen!

NW+ Belastungen im Lockdown

Perspektivlosigkeit in der Pandemie: Mehr Suizidversuche bei Jugendlichen

Pandemie

Während Corona-Lockdown: 500 Kinder nach Suizidversuchen auf Intensivstationen

Startseite > Welt

Corona-Studie: Dreimal mehr Kinder nach Suizidversuch auf Intensivstation als vor Corona

Schlafstörungen

gedrückte Stimmung

Konzentrationsstörungen

Suizidgedanken

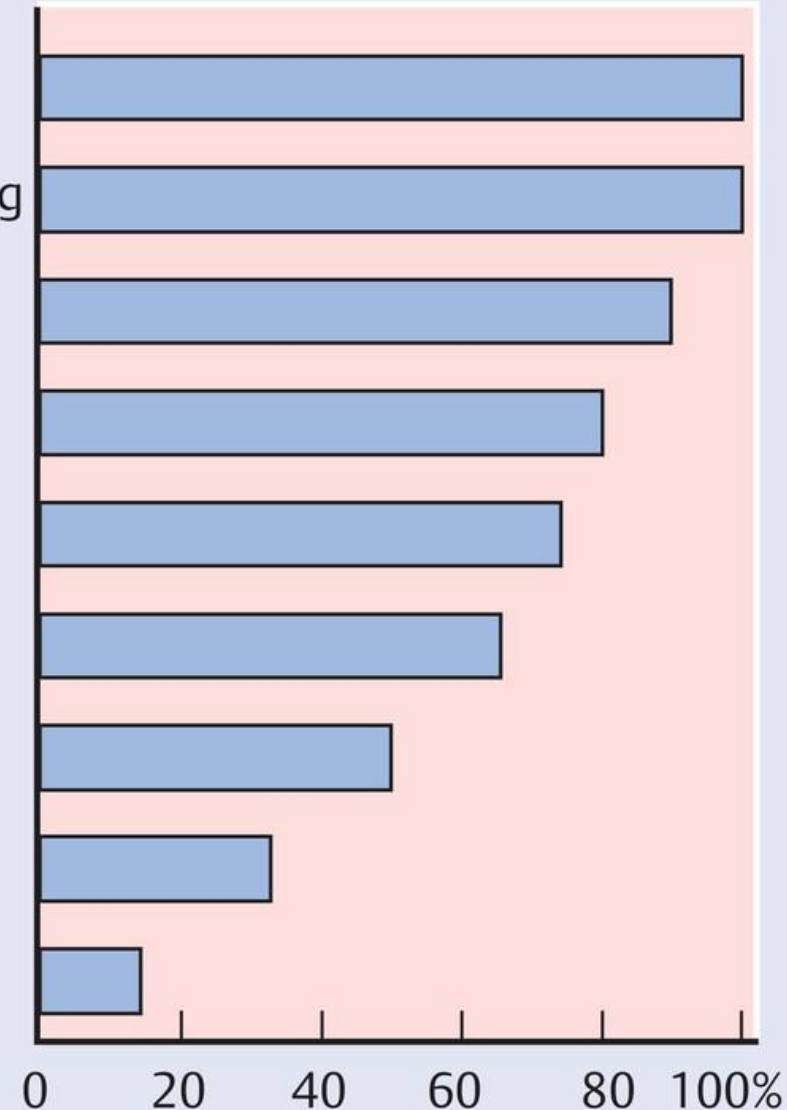
Müdigkeit

Appetitstörung

Hoffnungslosigkeit

Wahnideen

Suizidversuche





Bsp. aus dem echten Leben.

In der Nacht vom 26.12.22 hat sich ein Kollege des RD das Leben genommen.

Er ist zu diesem Zeitpunkt 34 Jahre alt gewesen, hat einen primär fröhlichen Anschein gemacht, immer viel gelacht, ist immer sehr Hilfsbereit gewesen, war in vielen sozialen Kreisen sehr aktiv (Rettungsdienst, Feuerwehr, Tafel, Sport, Familie mit Kinder,...).

Aus seinem Abschiedsbrief stellte sich heraus, dass er in der Kindheit ein traumatisierendes Erlebnis erlitt, welches ihn belastete und eigentlich auch dachte im Griff zu haben. In der Kombination von Problemen in seiner Liebesbeziehung, welche als niedergelegt galt, der Eigenschaft nur schwer bis gar nicht über eigene Probleme zu sprechen, hat es ihn überkommen und er hat keinen Ausweg mehr gesehen. Er hat in Form eines Bildes einen Suizid angekündigt und auf weitere Nachfragen nicht mehr reagiert. Die Sendung des Bildes ging an seinen Bruder, welcher auch ein enger Vertrauter war. Dieser arbeitet ebenso im RD und hat anschließend mit allem was in seiner Macht stand versucht ihn zu finden.

Leider ist es trotz aller Bemühungen mit RD und Polizei (Handyortung) nicht möglich gewesen ihn rechtzeitig zu finden und zu retten.

Schizophrenie

- Das Durchleben akuter Psychosen
- Pat hören Stimmen
- Verfolgungswahn
- Kompletter Verlust zur Wirklichkeit möglich
- Phasenweise
- Dauerhaft
- Gestörte Affektivität durch aufeinander folgend stark wechselnde Gefühlssituationen
- Gefühlsleere, starre Mimik, Teilnahmslosigkeit, Vermeiden von Augenkontakt
- Fälschlicher Weise Bezug zur „gespaltenen Persönlichkeit“





Schizophrenie Video



Prävention

Wen betrifft es?

Was ist Voraussetzung für uns selbst?

Eigene seelische Verfassung relevant?

Wie sieht es mit euch selbst aus?

Hattet ihr bereits Situationen/Einsätze die ihr mit euch tragt?



Wen betrifft es?



Man kann nie sagen wer welche Erlebnisse gemacht hat, die einem im späteren Lauf des Lebens „einholen“ obwohl man dachte, dass man es verarbeitet hätte. In Wirklichkeit drücken wir viele belastende und schwere Situationen einfach auf Seite und ignorieren diese. (Sich füllende Fass)
Gerade in Berufen in denen man viel mit Schicksalsschlägen, Tod, Vergangenheit oder momentanen Situationen der Patienten zutun hat, kann es insbesondere durch Stress, Bilder, Situationen, Geschichten von Patienten oder auch vieles anderes dazu kommen, dass wir uns damit belasten (MFP).

Zudem hat jeder auch noch ein Privatleben, welches für jeden auf die eigene Art und Weise eine Belastung darstellen kann.

Bitte auch nicht die persönliche Belastungsgrenze vergessen!



Was lernen wir aus dem Ganzen?

In einer kritischen Situation die eine erfahrene Kollegin betraf

Frage an MFP: Was würdest du beim Patienten tun?

Antwort: Ja das ist doch klar, aber bei mir ist es etwas Anderes.

Passt auf euch auf und hört auf euer Inneres! Als MFP sind wir oft dazu geneigt unsere eigene Situation nach hinten zu stellen und belasten uns immer weiter, gehen zur Arbeit obwohl es uns nicht gut geht.



Notwehr

- § 32 StGB
- Wer eine Tat begeht, die durch Notwehr geboten ist, handelt nicht rechtswidrig.
- Notwehr ist die Verteidigung, die erforderlich ist, um einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff von sich oder einem anderen abzuwenden.



Rechtfertigender Notstand

- § 34 StGB
- Wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leben, Leib, Freiheit, Ehre, Eigentum oder ein anderes Rechtsgut eine Tat begeht, um die Gefahr von sich oder einem anderen abzuwenden, handelt nicht rechtswidrig, wenn bei Abwägung der widerstreitenden Interessen, namentlich der betroffenen Rechtsgüter und des Grades der ihnen drohenden Gefahren, das geschützte Interesse das beeinträchtigte wesentlich überwiegt.
- Dies gilt jedoch nur, soweit die Tat ein angemessenes Mittel ist, die Gefahr abzuwenden.



Und bist du nicht willig, so brauch' ich Gewalt.
(Johann Wolfgang von Goethe)



Die Zwangseinweisung

Behandlung nach den Unterbringungsgesetzen (UBG und PsychKG)

Nach den Unterbringungsgesetzen UBG und PsychKG kann **gegen seinen Willen in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik untergebracht** werden, wer an einer psychischen Krankheit oder an einer krankheitswertigen psychischen Störung leidet **und deswegen eine Gefahr für sich selbst oder die öffentliche Sicherheit und Ordnung darstellt**. Zwischen den Unterbringungsgesetzen der verschiedenen Bundesländer bestehen erhebliche Unterschiede.

Ablauf in Aachen und Umgebung:

- RD stellt Problematik fest
- Nachforderung NEF, Ordn. Amt, Pol.
- Kontrolle durch NA und OA ob wirklich indiziert
- Auftrag an Pol und RD Pat an KH unter Voranmeldung zu transportieren
- Durchführung des Transportes unter Pol Begleitung.
- Innerhalb von 24h muss ein Richter den Pat sichten und entscheiden wie es weiter geht.



Was ist Voraussetzung für uns selbst?

Zuerst müssen wir verstehen womit alles beginnt und wo man ansetzen kann.

Wertfrei sein.

Idealerweise mit sich selbst im Reinen sein.

Ein Grundverständnis der Erkrankungen haben.

Es ist nicht euer Ziel den Patienten zu heilen, es ist euer Ziel den Patienten aus seinem Wahn herauszuholen.

Nicht Lügen und immer mit offenen Karten spielen. (Auch wenn manchmal etwas verschleiert)

Rechtliches Wissen!



Mögliche Fallstricke von eurer Seite

- Unser Auftreten kann schon von Beginn an entscheiden, wie die gesamte Situation verlaufen wird.
- Die Worte, die wir nutzen können über die Kooperation des Patienten entscheiden.
- Unsere Körpersprache sagt deutlich mehr über uns aus als es uns lieb ist.
- Blickführung kann gerade bei hyperaktiven, schizophrenen sowie depressiven Patienten das Vertrauen zu euch in Frage stellen
- Ein nicht Ernst nehmen der Situation, sowie Verständnislosigkeit
- Ein Missachten des emotionalen Zustandes
- Lügen



Kann sich als MFP darauf vorbereiten um Schlimmeres abzuwenden?

JA! Wenn „man“ denn will!

Doch wer ist dieser so genannte „man“?

Es gibt gewisse Grundsätze, die als Helfer, Betreuer, Therapeut, Arzt, Retter, Freund eingehalten werden sollten bzw. müssen. Sofern man es im Sinne des Patienten auf friedliche Art und Weise verlaufen lassen möchte.

Es kann natürlich immer passieren, dass es zu körperlichen Auseinandersetzungen kommt. Doch diese sind sehr oft auch Grund einer zu starren Kommunikation, indiziert durch den Helfenden. Wenn Eskalation bereits im Vorfeld vermutet oder allgemein für möglich gehalten wird, sollten **IMMER** weitere Hilfskräfte im direkten Umfeld sein! (Wenigstens in Wortreichweite)

Drogen haben verschiedene Wirkungen und können somit auch dynamische Situationen verursachen bei denen es schnell sehr sprunghaft werden kann. Aufgedreht und plötzlich Bewusstlos genauso umgekehrt...

Ohne Medikamente und Körperlichkeit

Rapport ist unser Ziel

Rapport bedeutet, Menschen auf ihrem Niveau anzusprechen und deren Sprache zu verwenden, um sie von Gedanken zu überzeugen, die sie **nicht** verstanden hätten, wären sie in einer **anderen** Form dargestellt worden.

Rapport ist die Fähigkeit, die Welt eines Anderen zu betreten und zu ihm **eine Brücke** zu bauen.

Es ist die Kunst, die Unterstützung und **Mitarbeit des Patienten** zu erhalten, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen.

Rapport ist eine Beziehung, die gekennzeichnet ist durch **Zustimmung**, gleiche Richtung oder Ähnlichkeit.

Wenn der Rapport vorhanden ist, dann **verschwindet** der Widerstand. Rapport bedeutet, einen tiefen Kontakt zu dem **Unbewussten** des Anderen aufzubauen.

Doch wie stellen wir eine solche Verbindung her?



Kommunikation ist der Schlüssel

Wenn die Kommunikation nicht auf einer Ebene stattfindet, kommt es sehr schnell zu Missverständnissen. Um dies zu Vermeiden gibt es aus dem NLP (NeuroLinguistik) smarte und praktische Techniken die im Notfall das Leben sehr stark erleichtern können.

Als erstes muss man verstehen dass es innerhalb der Kommunikation 3 Ebenen zu bestreiten gibt, um zu dem höchsten Ziel, der 4. Ebene, zu gelangen.



-Spiegeln:

Körperliches Sich-Anpassen an Haltung, Gestik, Atmung, Mimik, Bewegungen oder Gewichtsverlagerung, Muskeltonus...

Hier passt man sich wie ein Spiegel an.
(nicht übertreiben!)



-Pacing:

Sich im gesamten visuellen und auditiven Ausdrucksverhalten an den anderen anzupassen (Nicht Duplizieren!).

Die andere Person wird dort abgeholt wo sie steht.

Bsp.: Sprachtempo, Rhythmus, Tonlage... Alles was das Spiegeln beinhaltet fällt hier auch mit hinein.



-Matching:

Ist eine Ebene umfassender und bezeichnet dass sich Angleichen an Sprachstile sowie Sprachmuster.



-Leading:

Nachdem man sich dem Patienten eine Weile angeglichen hat und den Rapport hergestellt hat, kann man dazu übergehen , ihn zu führen und auf der Basis von Rapport und im Sinne des Win-Win-Prinzips zu einem bestimmten Ziel oder Ergebnis hinzuführen.

Grundannahmen 6 - 10 des NLP um eine möglichst gute Patientenbetreuung zu gewährleisten

Menschen haben bereits alle Ressourcen für jede gewünschte Veränderung in sich.

Das Ziel des NLP ist es, diese Ressourcen im richtigen Moment zur Verfügung zu haben und in optimaler Weise einzusetzen.

Widerstand beim Patienten bedeutet mangelnde Flexibilität auf Seiten des Beraters.

Widerstand resultiert nicht aus Bösartigkeit des Gegenübers, sondern ist ein Hinweis auf fehlende Rapport, der durch (erneutes) Herstellen von Rapport ausgeräumt werden kann.

Die Bedeutung der Kommunikation liegt in der Reaktion, die man erhält.

Man kommuniziert, um von seinem Gegenüber eine erwünschte Reaktion zu erhalten. Bleibt diese aus, so ist die eigene Botschaft nicht angekommen. Anstatt darauf negativ zu reagieren, ist es sinnvoll, das eigene Verhalten zu ändern.

Wenn etwas nicht funktioniert, tue etwas anderes.

Wenn wir flexibel sind, dann können wir jede Reaktion als Ergebnis und damit als wertvolle Information ansehen.

In der Kommunikation gibt es keine Fehler, sondern nur Feedback, aus dem wir lernen können.

Jede Reaktion und jedes Ergebnis kann als Feedback und als Möglichkeit zum Lernen genutzt werden. Als Feedback geben sie wichtige Hinweise darüber, ob ein Lösungsweg geeignet ist oder nicht, und laden dazu ein, neue Wege zu suchen.



In der Praxis

Eigene Erfahrungen?

Gibt es Worte oder allgemeine Handlungen die man besser lassen sollte?

Beispiele für eine praxisnahe Umsetzung?

Was sollten wir beachten um den Patienten gut zu führen und um alles zu deeskalieren?

Eigenschutz



Eigene Erfahrungen

Die eigenen Erfahrungen sind **eure** Landkarte, **eure** Werte und **eure** Moralvorstellungen.

Jeder sieht die Welt durch eine andere Brille.

Ihr solltet es **unbedingt vermeiden** aus den eigenen Werten zu schlussfolgern und diese eurem Patienten aufzudrängen.

Menschen treffen innerhalb ihres Modells der Welt grundsätzlich die beste ihnen subjektiv zur Verfügung stehende Wahl.

Euer Erfahrungspool kann jedoch dabei eine grobe Orientierung bieten.

Die Landkarte ist nicht das Gebiet

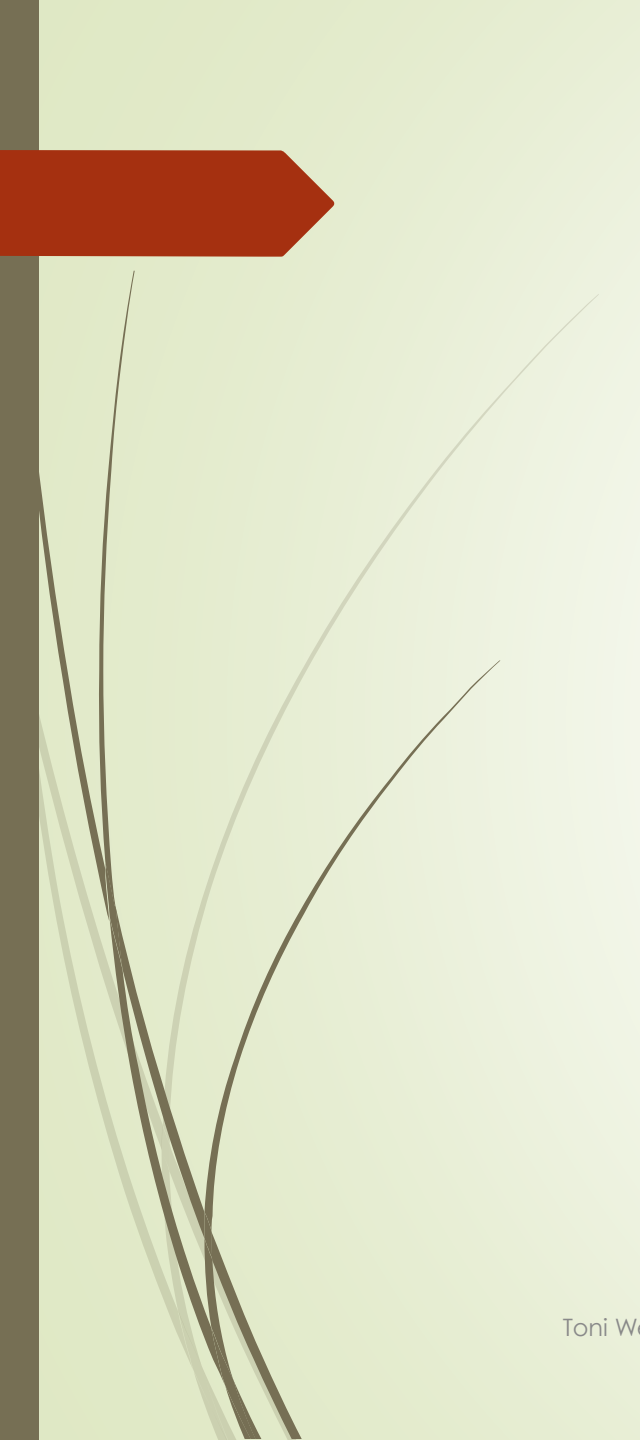
Worte und Körperhaltung

Kommunikation:

- Körpersprache 55%
 - Mimik
 - Gestik
- Sprache 45%
 - Tonfall, -lage, -höhe
 - Inhalt 7%

Kann man „Nicht
Kommunizieren“?



- 
- Ein Großteil der Kommunikation ist bereits gelaufen, bevor wir den ersten Ton gesagt haben.
 - „Man kann nicht nicht kommunizieren (Paul Watzlawik)
 - Sobald zwei Personen sich gegenseitig wahrnehmen können, kommunizieren sie miteinander, da jedes Verhalten kommunikativen Charakter hat.



Gibt es Tools die uns Helfen können?

Die Wörter „Wieso, Weshalb, Warum, Aber“ sind möglichst zu vermeiden!

Diese lösen ein Hinterfragen der Sinnigkeit aus und nicht unbedingt ein Interesse an den Hintergründen der momentanen Situation.

Wir wollen die Gründe und Ziele wissen, dann fragt auch aktiv nach diesen!

(„Hat es einen Grund dass Sie...?“ „Was ist hier gerade Ihr Ziel?“)

Körperhaltung sollte immer Stabil und aufrecht sein!

Wenn der Patient merkt dass er „Geistig sowie Körperlich“ über euch steht, aus Welchem Grund sollte er euch dann Respekt zollen?



Toni Weidenbecher





Gestik und Mimik

Blickführung, Handhaltung, Ruhe und Ausstrahlung versuchen bewusst einzusetzen

Gesprächsführung

- Achtet auf eine klare sowie deutliche Aussprache! Ihr habt die Leitung und müsst diese auch mit Gerissenheit nutzen.
- Wenn ein Patient euch zu Nahe kommt oder Angst verursacht, dann sagt es.

Fazit?

- Kommunikation ist der „Schlüssel“ zur Deeskalation.
- Es gilt, sorgsam mit den eigenen verbalen und nonverbalen Kommunikationsmitteln umzugehen, um die Entstehung und Eskalation von Aggressionen und Gewalt zu verhindern oder zu unterbrechen.
- Besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang, neben dem „was ich sage“ (Inhalt), darauf zu achten, „wie ich es sage“ (Sprache, Stimme, Mimik, Gestik) und wie ich auftrete.

Was haben wir vergessen?



Eigentum von Kalter Stahl

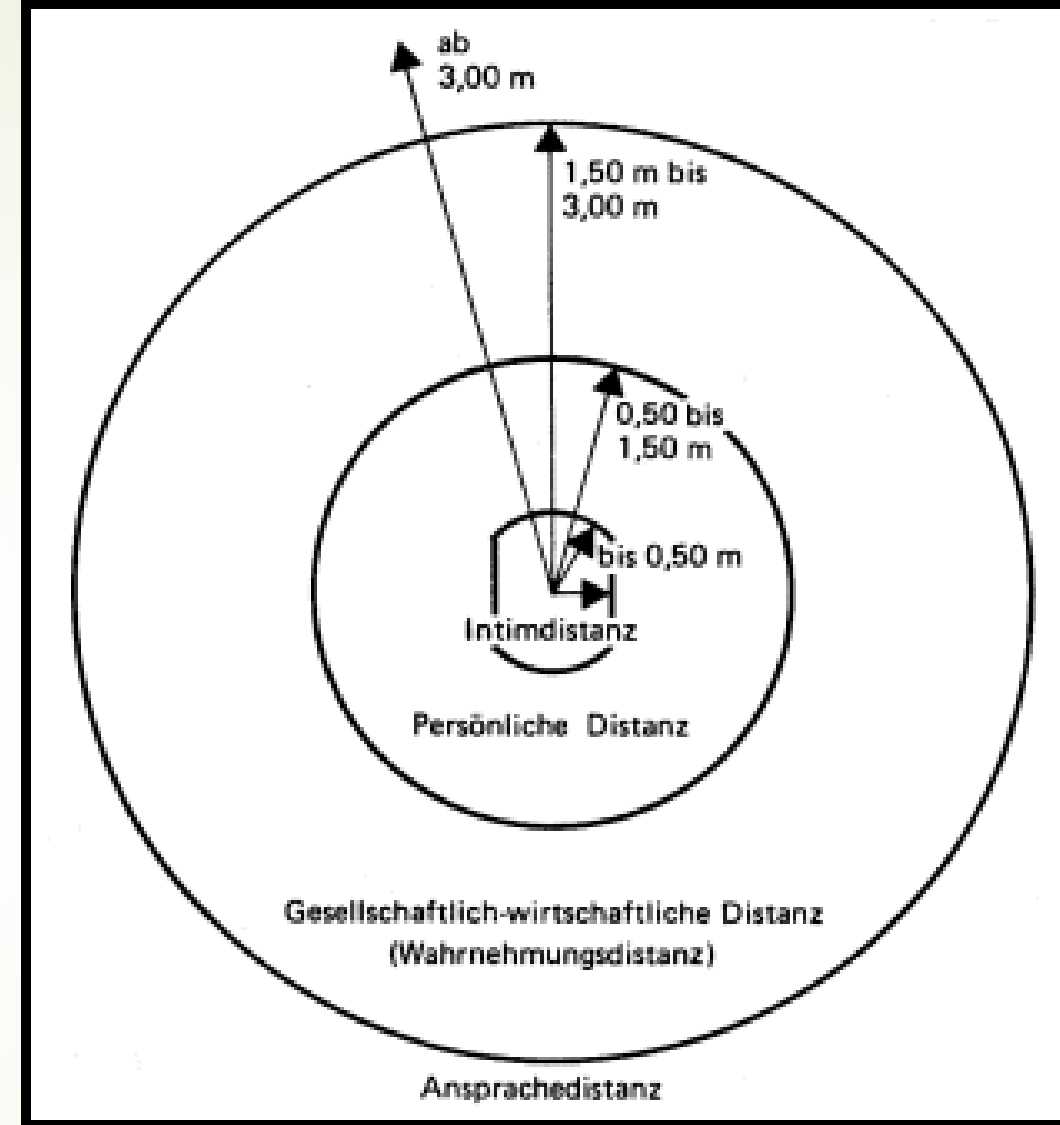


Eigentum von Kalter Stahl



Toni Weidenbecher

Sinn?





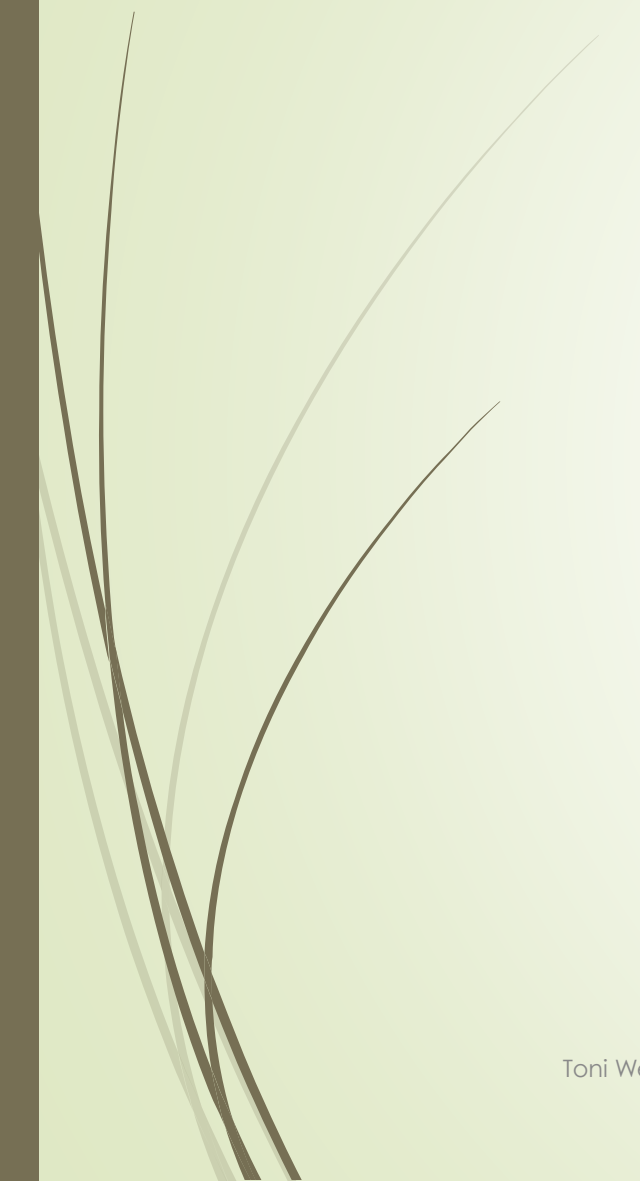
Immer auf den Eigenschutz achten!

- Euer Gegenüber kann in 1-1,5 Sekunden 3m Distanz überwinden und einen Angriff ausüben
- D. h. bei Gewalttätigen / Aggressiven sollte diese Distanz mindestens eingehalten werden
- Messer werden von unglaublich vielen Personen „am Mann“ getragen
- Diese lassen sich sehr leicht verstecken und unvermittelt einsetzen
- Die Angriffsschwelle sinkt seit Jahren!!

TRAGODIE VON HERBORN

Polizist starb an Messerstichen in den Hals





Fragen?

Feierabend!



Toni Weidenbecher

Weitere Cartoons unter www.medi-learn.de/cartoons.